

PHÂN LOẠI ADENOMYOSIS TRÊN HÌNH ẢNH HỌC VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN: TẠI SAO CẦN CHUẨN HÓA?

BS. Lê Khắc Tiến

Trung tâm siêu âm BV Mỹ Đức (MDU)

Nhóm nghiên cứu LNMTC & Adenomyosis BV Mỹ Đức (SEAMD)



1. Sự thiết đồng nhất trong chẩn đoán
2. Tiêu chuẩn MUSA và cách thực hiện
3. Tương quan giữa đặc điểm Adenomyosis theo MUSA và sức khỏe sinh sản
4. Trường hợp lâm sàng
5. Thông điệp mang về

Sự không đồng nhất trong mô tả hình ảnh học...

II. MÔ TẢ KẾT QUẢ

1. TỬ CUNG :

- Tư thế : Ngả Trước
- DAP: 70 mm
- Cấu trúc cơ : KHÔNG Đồng nhất , Mặt SAU ĐÁY tử cung, có một nhân xơ GIOI
- Nội mạc : 4 mm
- Lòng tử cung

2. PHÂN PHỤ :

- Buồng trứng (P)
- Buồng trứng (T)

3. TÚI CÙNG : Không dịch

4. GHI NHẬN KHÁC :

II. MÔ TẢ KẾT QUẢ

1. TỬ CUNG :

- Tư thế : Ngả sau
- DAP: 51 mm
- Cấu trúc cơ : thành sau không đồng nhất
- Nội mạc : 13 mm
- Lòng tử cung : trống

2. PHÂN PHỤ :

- Buồng trứng (P) : có khối echo kém kt# 24*14 mm
- Buồng trứng (T) : bình thường

3. TÚI CÙNG : Không dịch

4. GHI NHẬN KHÁC : Chưa ghi nhận bất thường

III. KẾT LUẬN

LẠC NỘI MẠC TRONG CƠ TỬ CUNG VÀ BUỒNG TRỨNG PHẢI

HÌNH ẢNH SIÊU ÂM



KẾT QUẢ

TỬ CUNG: trung gian
Kích thước: 50 x 74 x 62 mm
(trước sau/dọc/ngang)

NỘI MẠC TỬ CUNG

- Bề dày: 07 mm
- Phản âm kém, đồng nhất
- Bờ nội mạc đều

CƠ TỬ CUNG:

- Phản âm kém không đồng nhất
- Thành trước dày hơn và không đối xứng nhau
- Trong cơ tử cung có nhiều đường sọc bóng lưng và rải rác có vài nang nhỏ
- Ranh giới giữa cơ tử cung và nội mạc không rõ

CỔ TỬ CUNG: Không có bất thường được nhìn thấy trên siêu âm

2 BUỒNG TRỨNG: bình thường

DỊCH CÙNG ĐỒ-DỊCH Ổ BỤNG: Không

... dẫn đến không đồng nhất trong...

Adenomyosis:

- ✓ Tần suất?
- ✓ Có gây hiếm muộn?
- ✓ Có gây AUB?
- ✓ Có liên quan đến biến chứng thai kỳ?
- ✓ Khi nào cần điều trị?
- ✓ Hiệu quả của các phương pháp điều trị?

Spotting between periods

Painful menstrual cramps

Painful periods

Infertility

Pelvic pain

Heavy menstrual bleeding

Blood clots during menstrual bleeding

Enlarged uterus

Longer menstrual cycles than normal

Impact of adenomyosis on in vitro fertilization outcomes in women undergoing donor oocyte transfers: a prospective observational study

Outcome was the implantation rate. The secondary outcomes were the clinical pregnancy, live birth, and miscarriage rates after ART.

Results: The presence of adenomyosis did not significantly affect the implantation, clinical pregnancy, or live birth rates. However, women with adenomyosis had a significantly higher miscarriage rate than those without adenomyosis (35.4% vs. 18.1%, respectively). This analysis assessed possible risk factors for each clinical outcome considered in the study and showed that adenomyosis

pregnancy. Studies focused on ART have shown that women with adenomyosis often experience lower success rates compared to their counterparts without the condition (Vercellini et al., 2014; Horton et al., 2019; Bourdon et al., 2022; Cozzolino et al., 2022). However, the existing literature presents conflicting findings; while some studies report a significant reduction in live birth rates (ABRs), others show no significant differences (Maggiore et al., 2014; Yan et al., 2014; Higgins et al., 2021). A major limitation of many

What – MUSA là gì?



IOTA



IETA



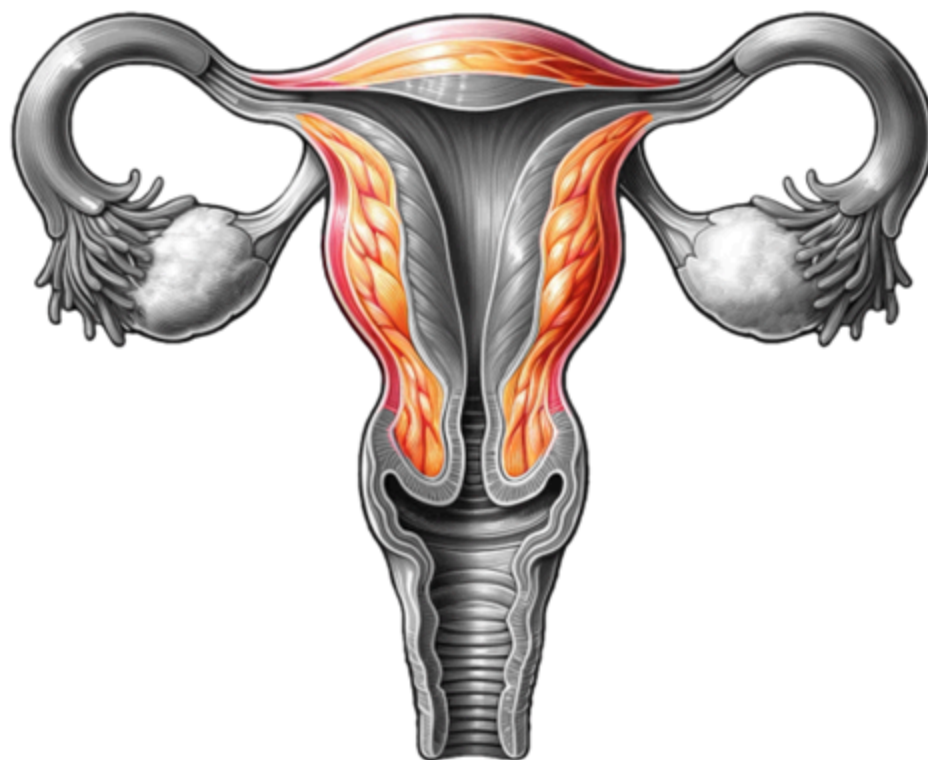
MUSA



IDEA



EPC



Nhóm Nghiên cứu MUSA

Nhóm Siêu âm đánh giá hình thái tử cung (Morphological Uterus Sonographic Assessment, MUSA) là nhóm nghiên cứu được thành lập nhằm mục đích tối ưu hóa chẩn đoán bệnh lý cơ tử cung, bao gồm u cơ lành tính, u mô liên kết tử cung ác tính và adenomyosis



What – MUSA là gì?

Dấu hiệu trực tiếp



Dấu hiệu gián tiếp



Nang trong cơ (cyst)



Bẫy: dễ chẩn đoán nhầm với

- Mạch máu
- Nang Naboth

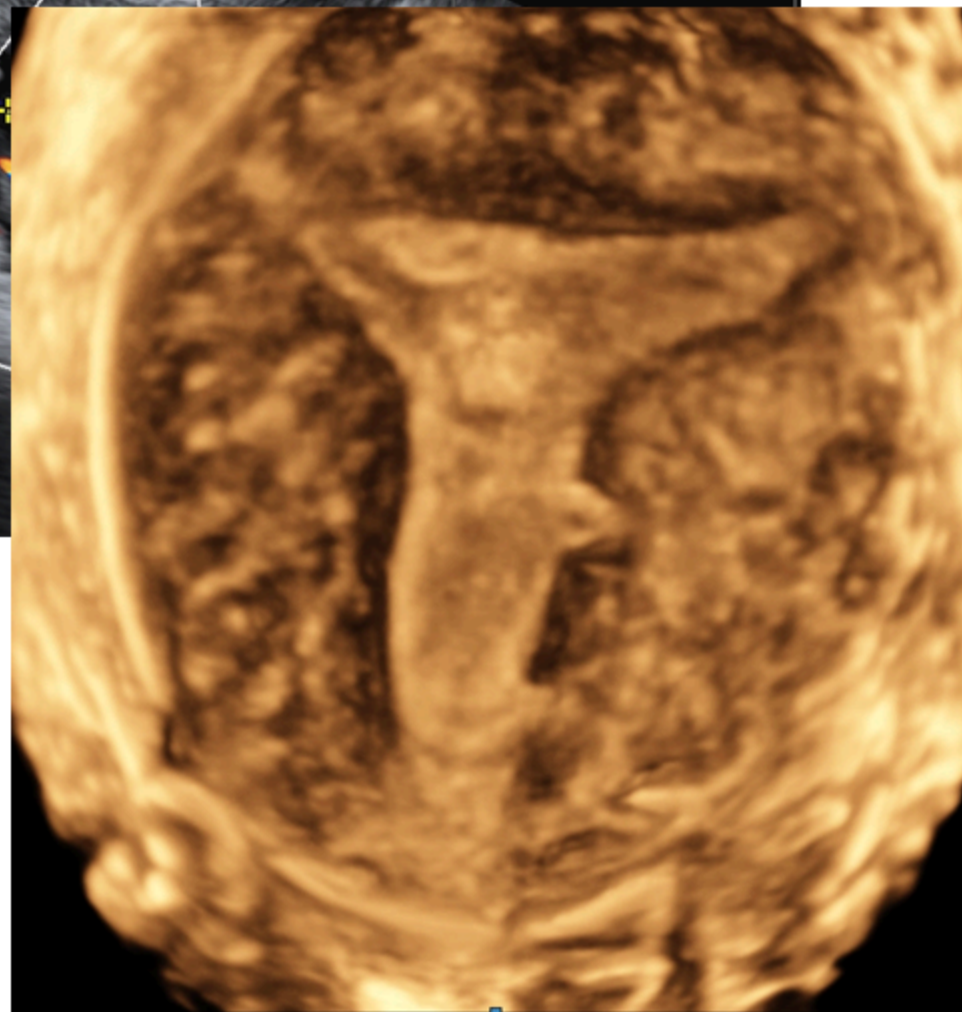
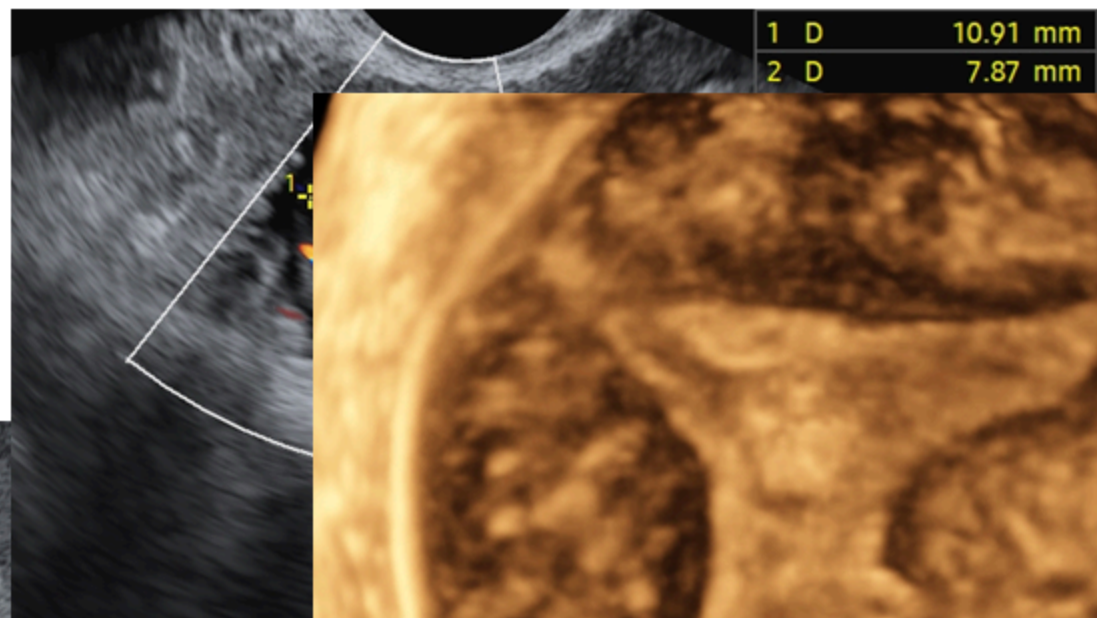
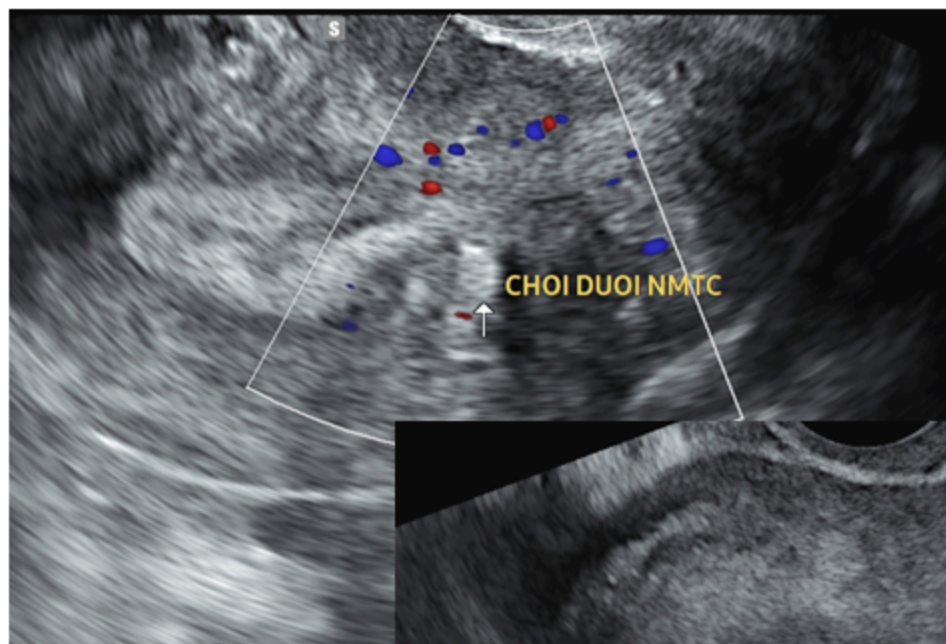


Bẫy: đảo tăng âm có độ đặc hiệu thấp, dễ chẩn đoán nhầm với

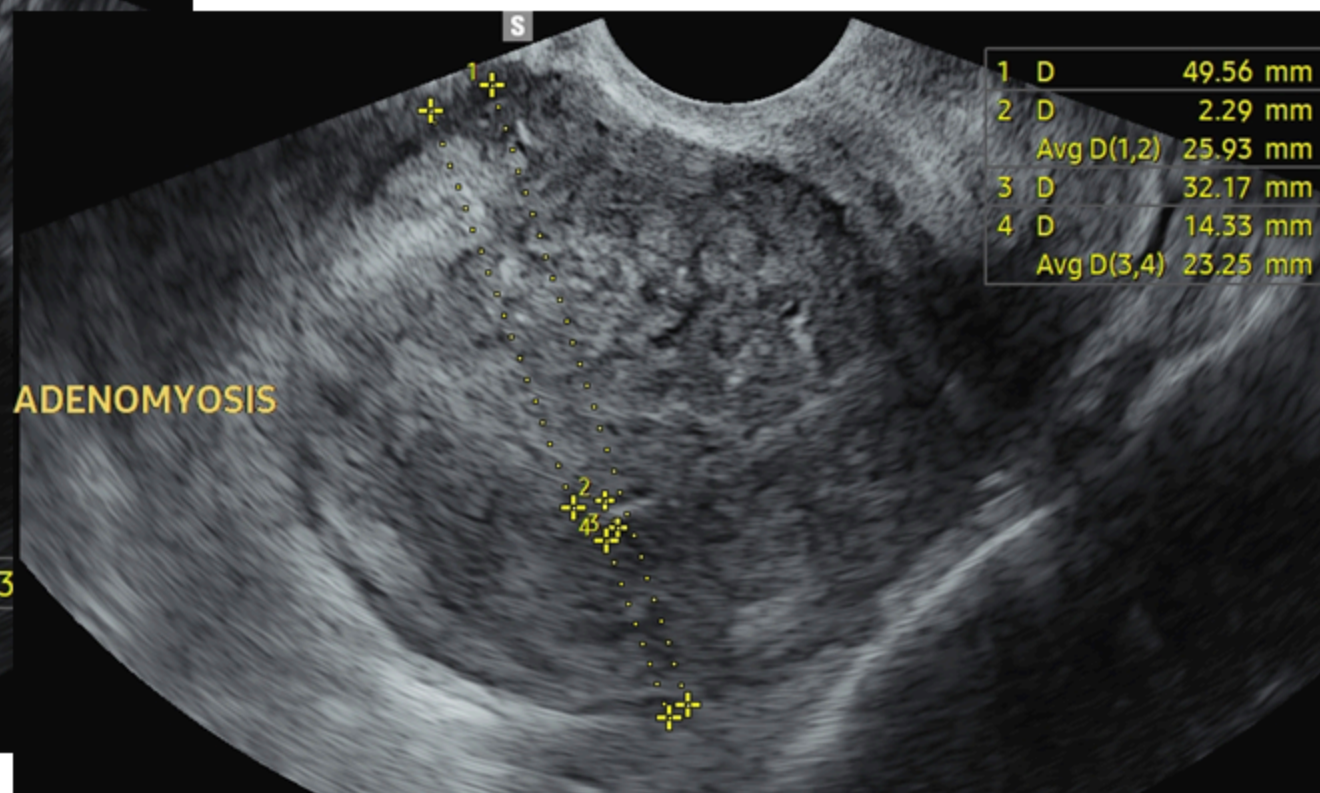
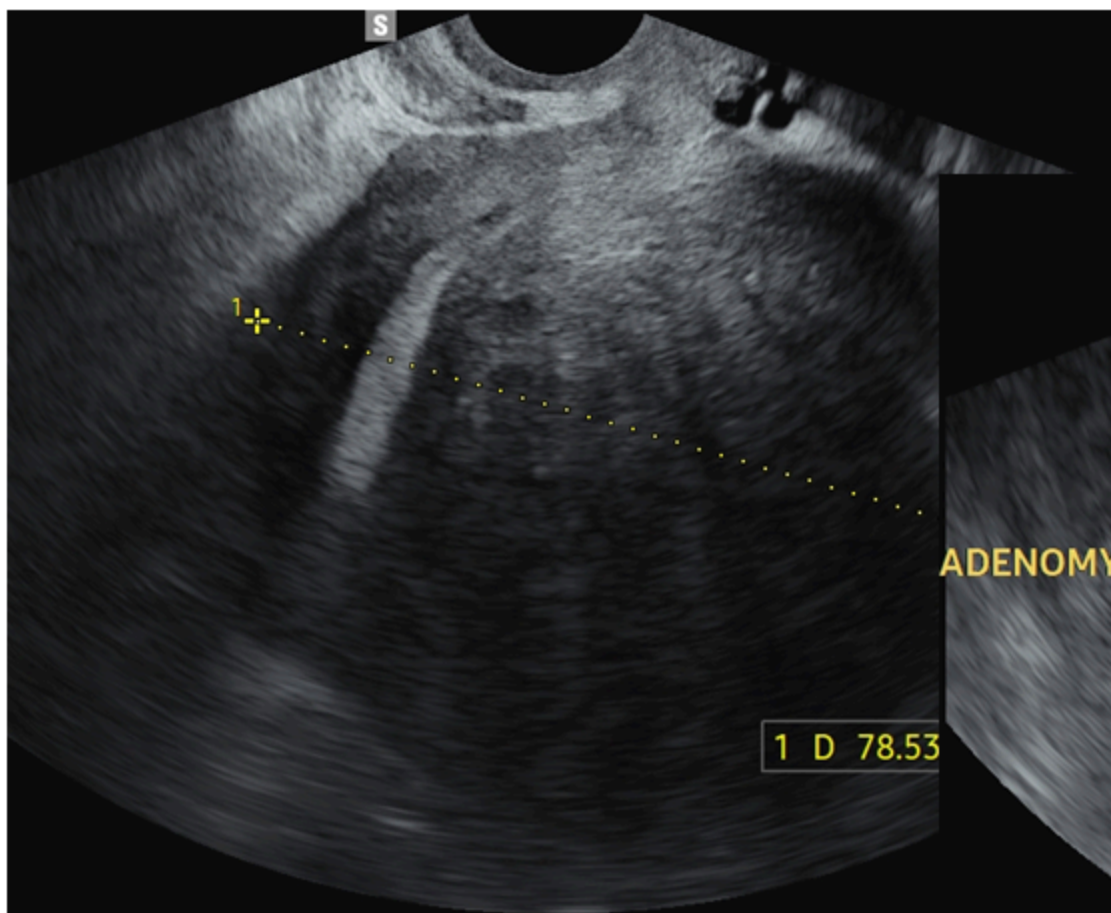
- Thành mạch máu
- Vôi hoá

Tip: không nên chỉnh gain quá cao, chỉnh Dynamic Range (DR)
trung bình

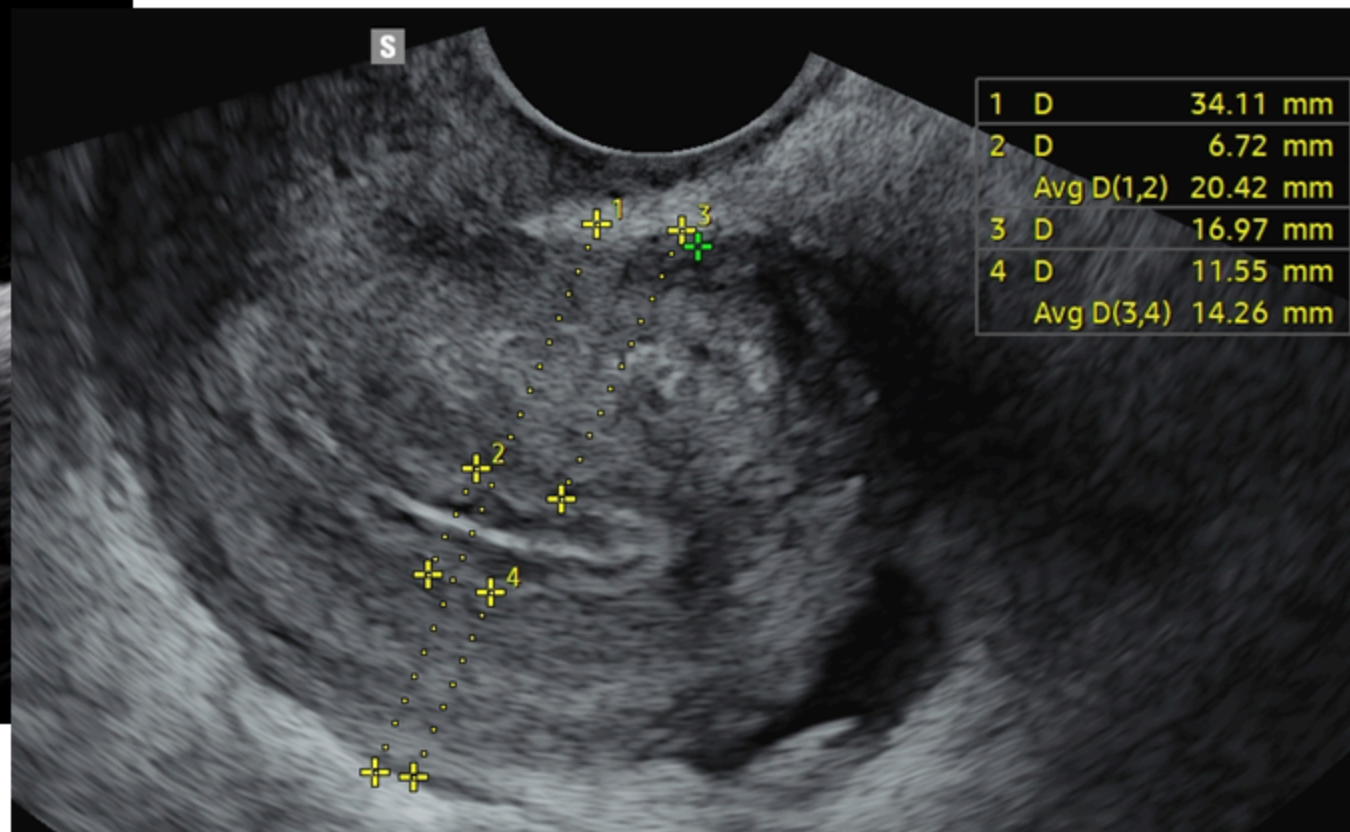
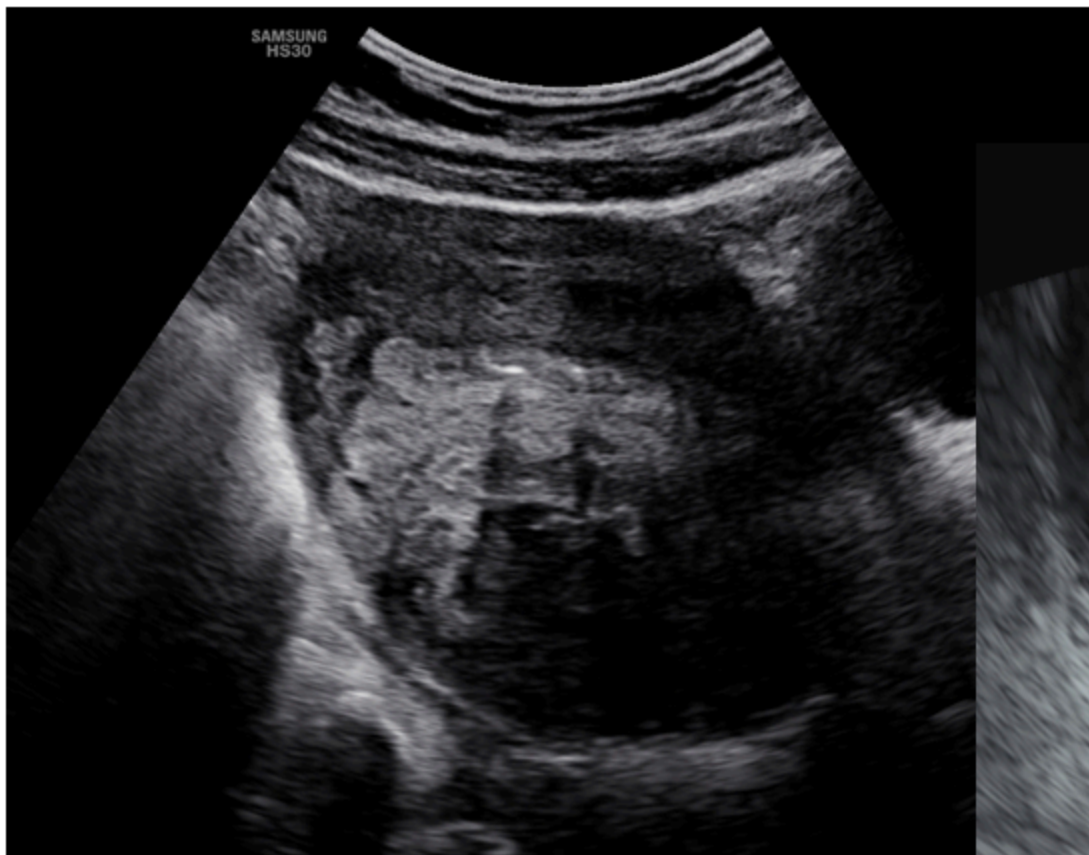
Đường sọc, chồi tăng âm dưới nội mạc



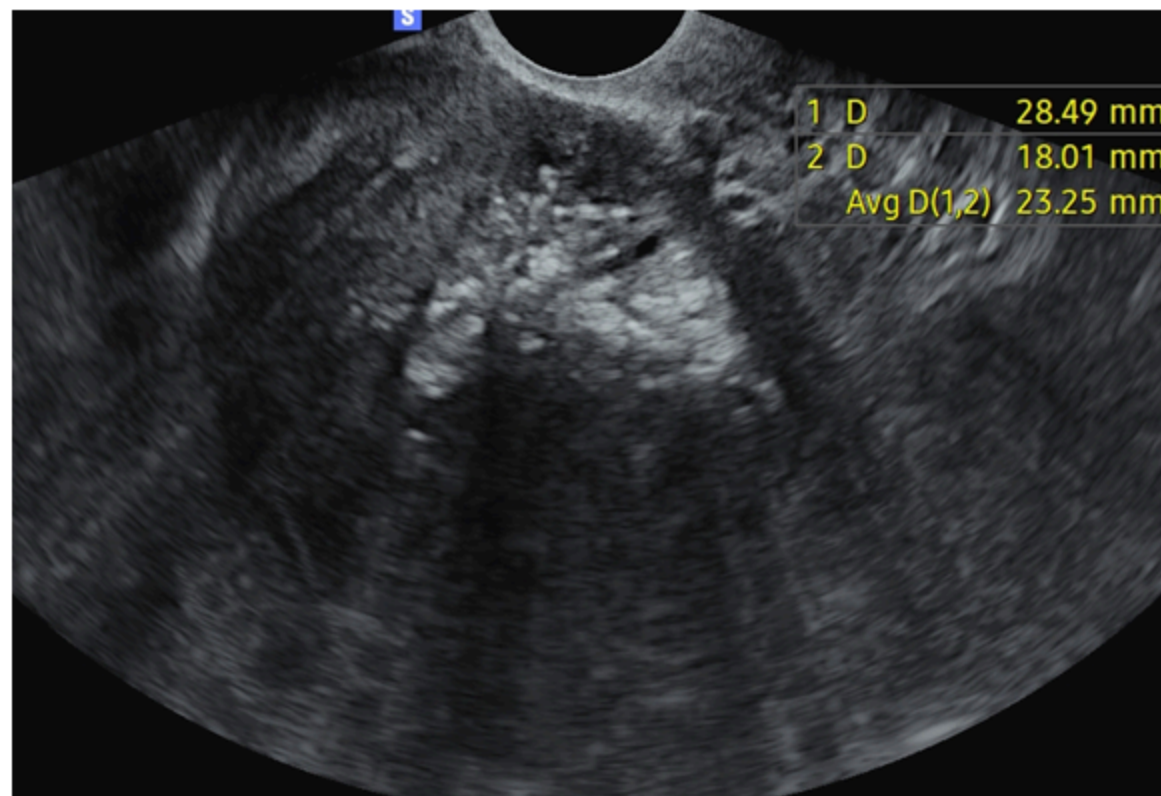
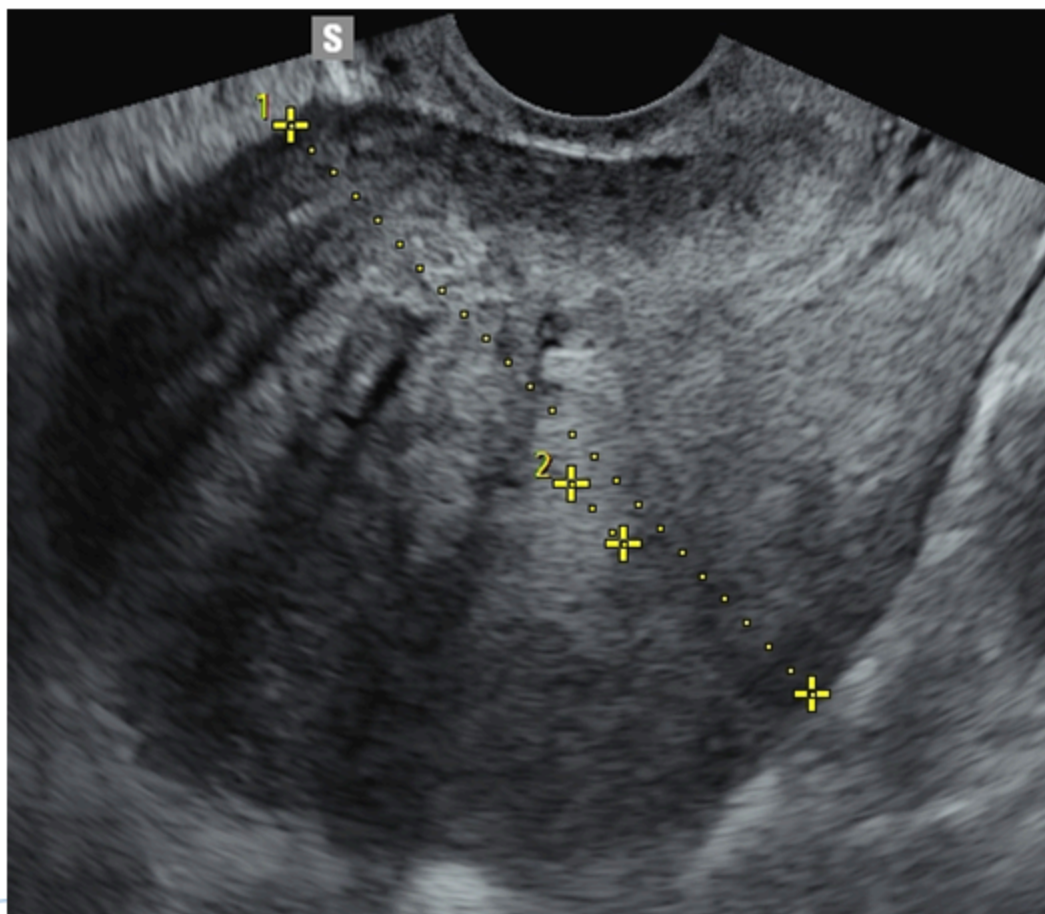
Tử cung hình cầu



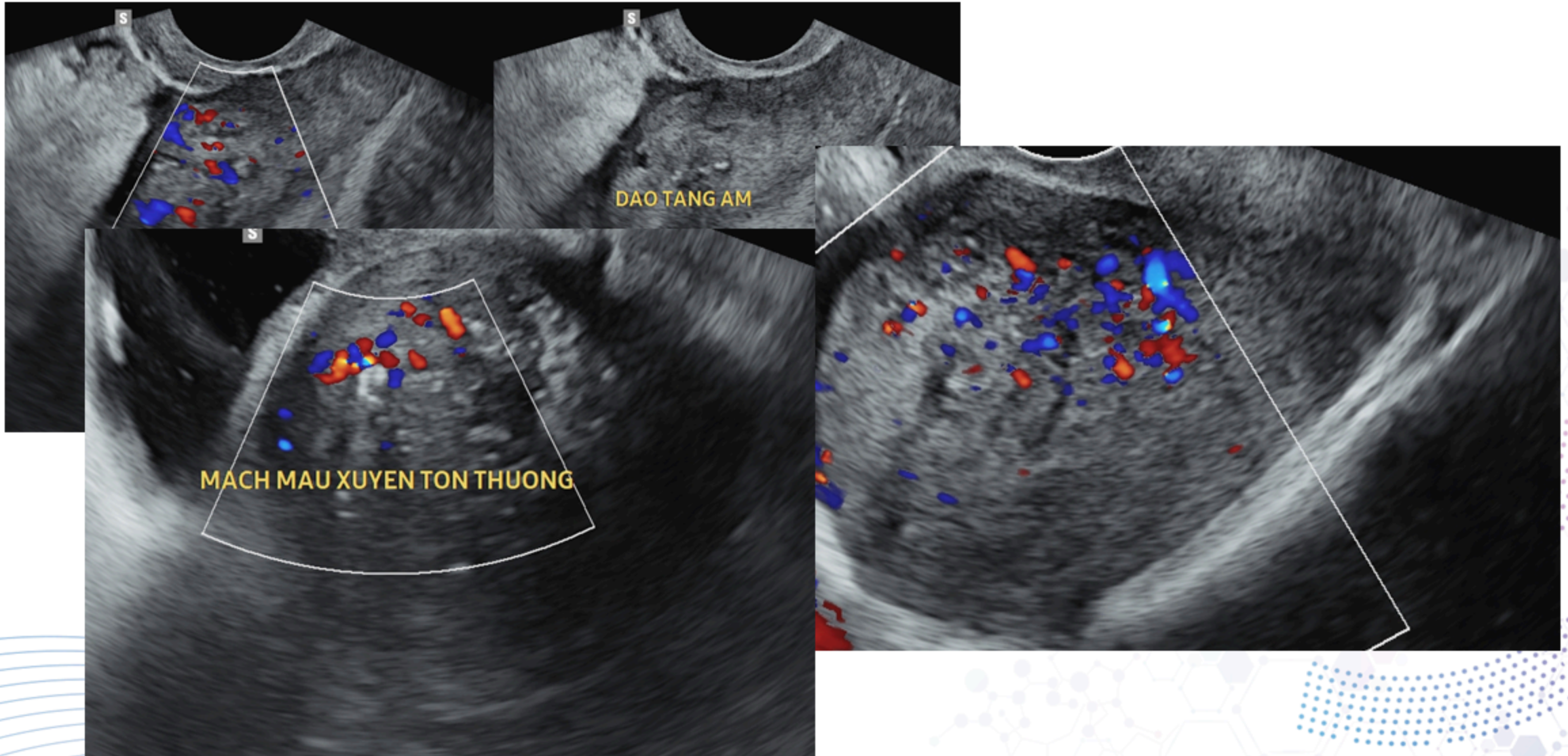
Dày thành tử cung không đối xứng



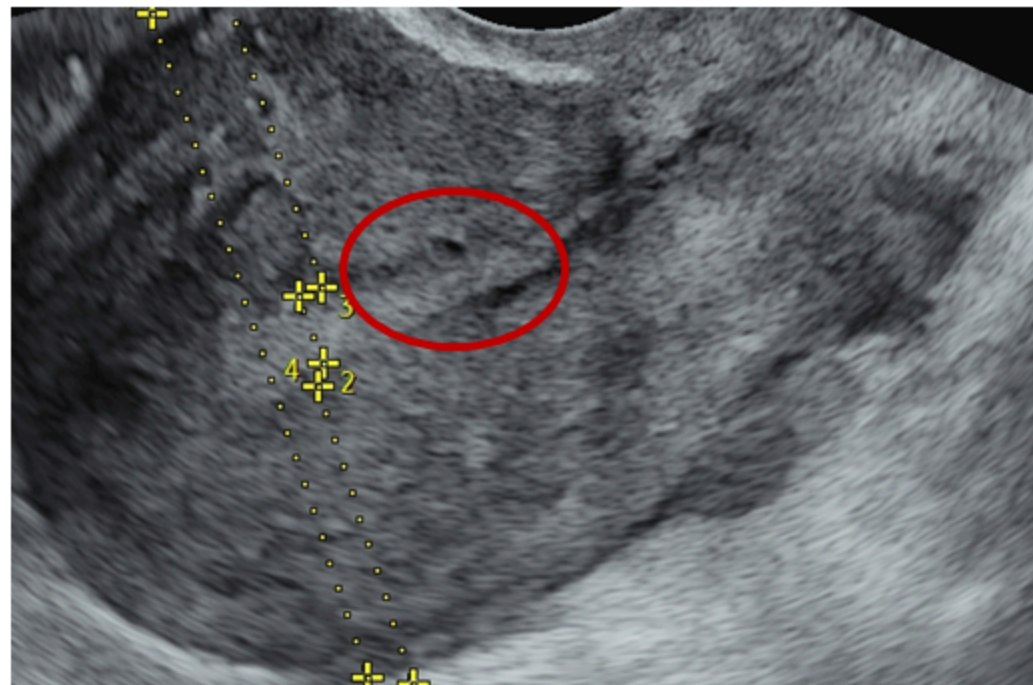
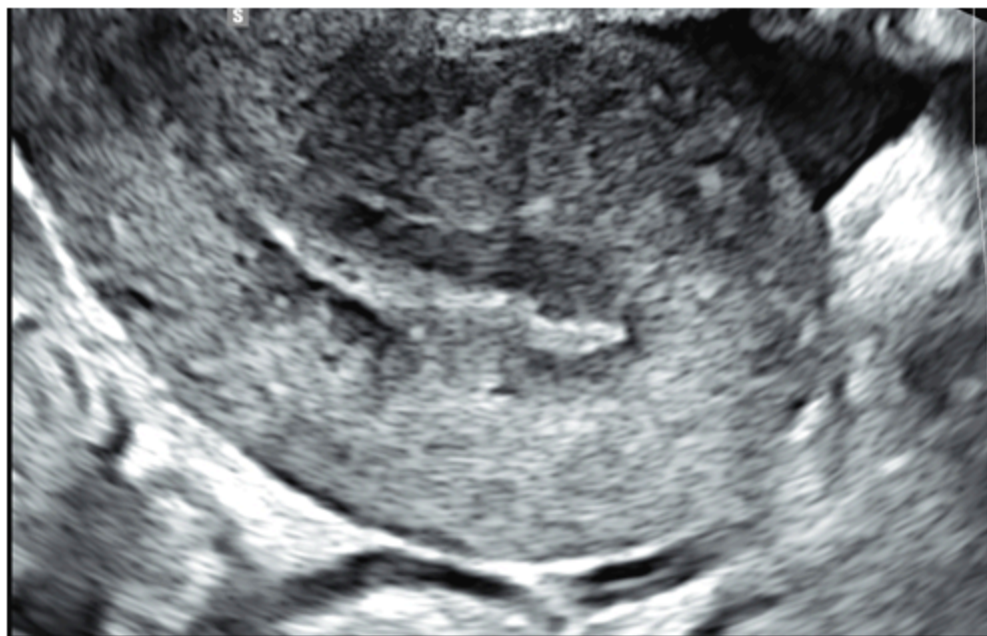
Bóng hình rẽ quạt



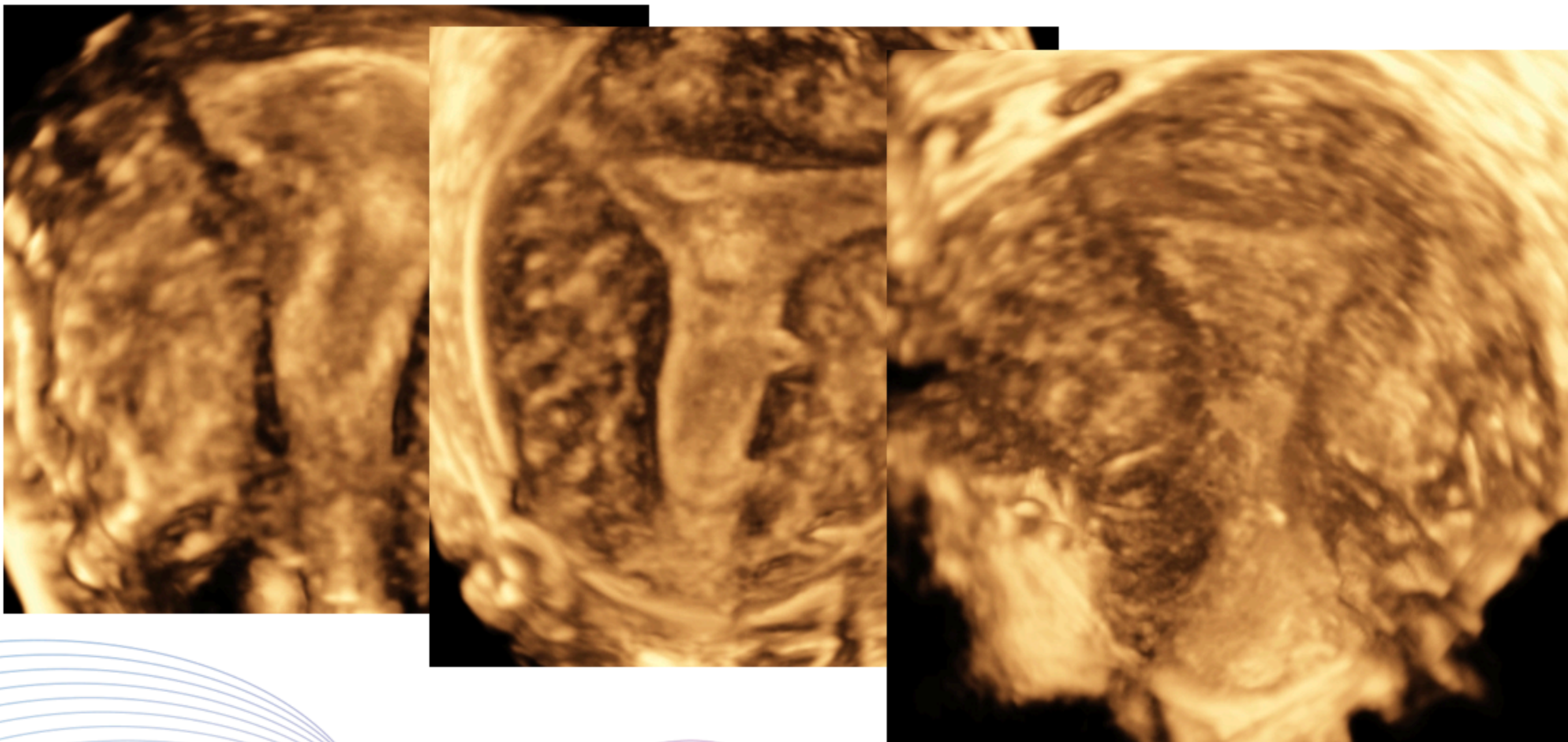
Mạch máu xuyên tổn thương trên Doppler



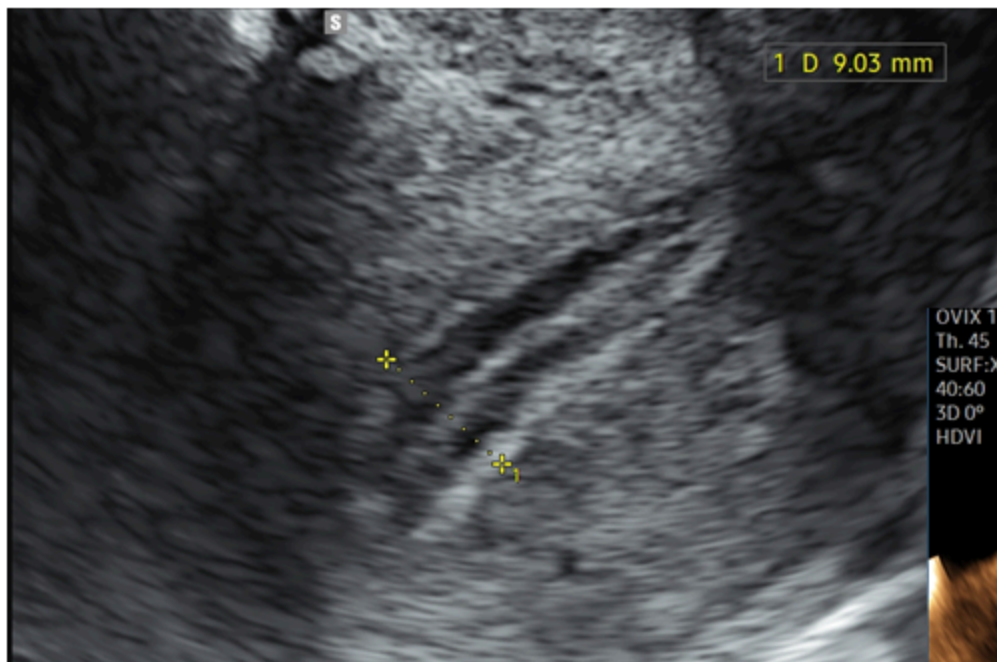
Vùng nổi không đều/ vùng nổi gián đoạn (2D)



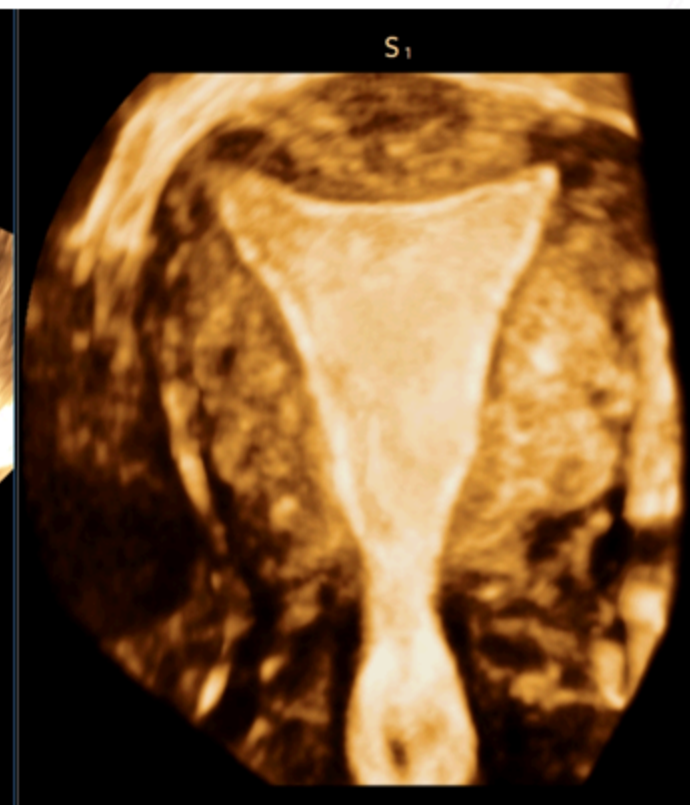
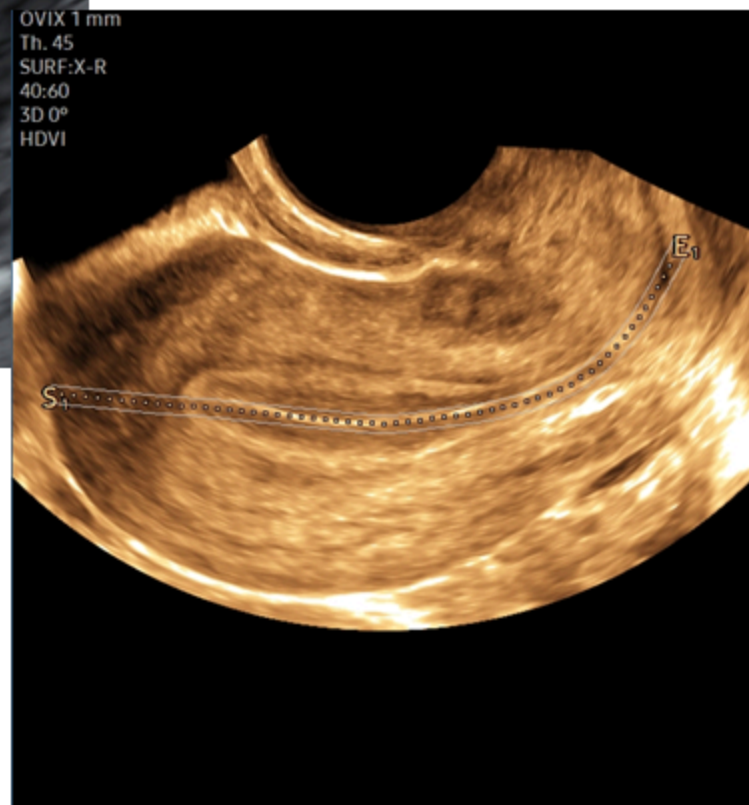
Vùng nổi không đều/ vùng nổi gián đoạn (3D)



Vùng nổi bình thường (2D/3D)



Vùng nổi bình thường trên siêu âm có thể loại trừ adenomyosis với độ nhạy 92% và độ đặc hiệu 31% (Tellum và cs., 2018)



Báo cáo kết quả?



Chỉ định: SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ ADENOMYOSIS

MÔ TẢ

TỬ CUNG

Tư thế: ngã trước
Đường kính trước sau: 47 mm
- Thành trước: 22 mm
- Thành sau: 20 mm

Nội mạc tử cung: 4 mm

Lòng tử cung: chưa phát hiện bất thường

* Đặc điểm adenomyosis:

- Mật độ cơ tử cung: không đều, ở thành sau tử cung có tổn thương với các đặc điểm:

Dấu hiệu trực tiếp:

- Nang trong cơ
- Đảo tăng âm

Dấu hiệu gián tiếp:

- Phổ Doppler có mạch máu xuyên tổn thương
- Vùng nổi: bình thường

- Phân loại: > 25% tổn thương được bao quanh bởi cơ tử cung lành

- Phân nhóm: tổn thương nằm ở lớp giữa của cơ tử cung

- Xâm lấn: tổn thương xâm lấn <25% cơ tử cung

- Kích thước tổn thương lớn nhất: 12x16 mm (thành sau tử cung)

- Dấu trượt khoang sau: có

- Adenomyoma: có

- HAI PHẦN PHỤ:

Buồng trứng phải: bình thường, di động kém, có một nang phản âm trống, kích thước 10 mm

Buồng trứng trái: bình thường, di động kém, dính với đáy tử cung, có một nang phản âm hỗn hợp dạng lưới, kích thước 26*18mm

- CÁC BẤT THƯỜNG GHI NHẬN KHÁC:

Kích thước tổn thương

KẾT LUẬN

ADENOMYOSIS DẠNG NANG THỂ KHU TRÚ, NHÓM 2, Ở THÀNH SAU TỬ CUNG

XÂM LẤN: NHẸ

NANG XUẤT HUYẾT BUỒNG TRỨNG TRÁI

Tương quan giữa đặc điểm Adenomyosis và triệu chứng

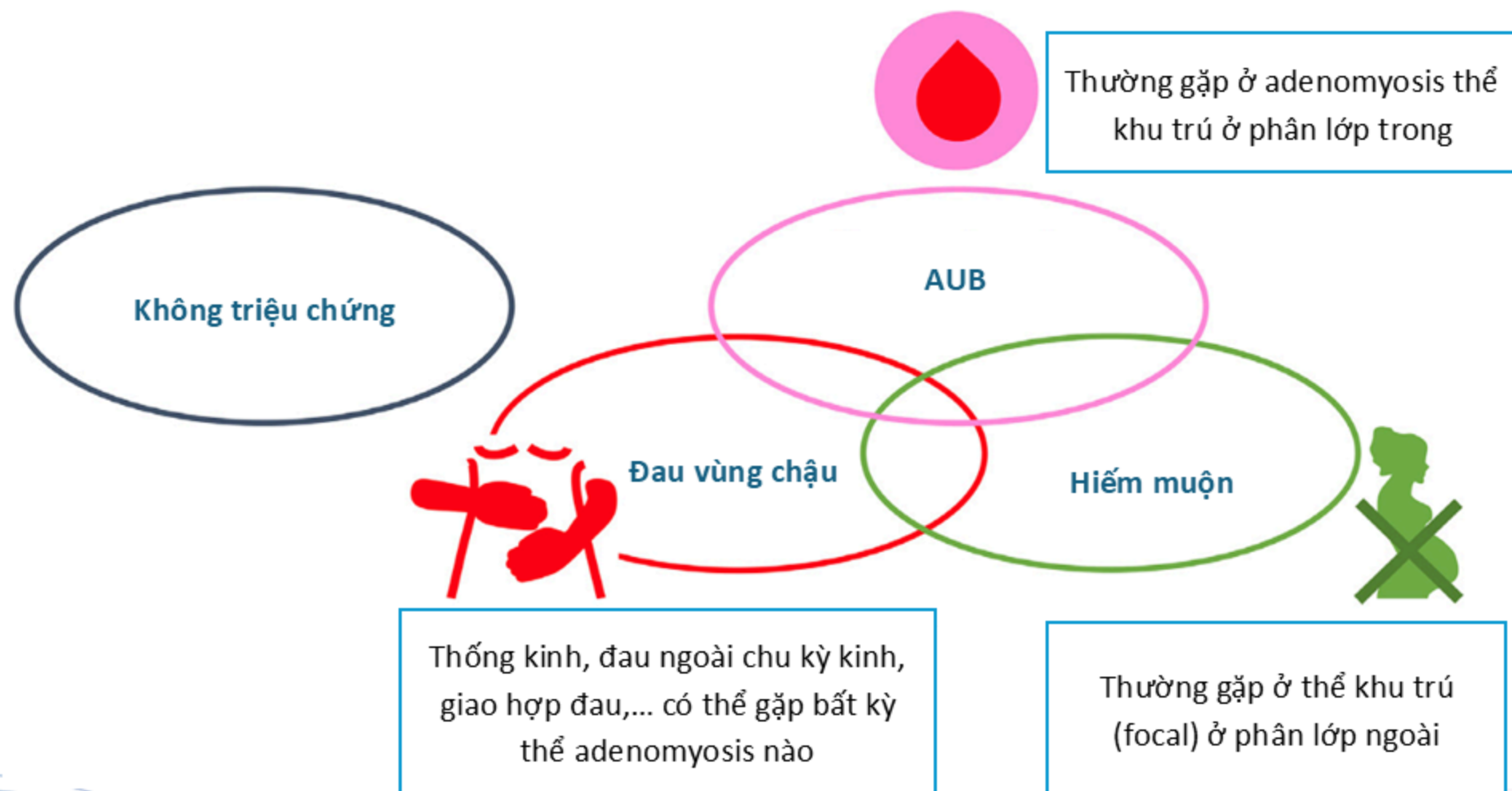
Đặc điểm adenomyosis	Triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ
Tổn thương ở phân lớp ngoài	Phụ nữ trẻ, ít mang thai hơn và kèm theo LNMTC ở những vị trí khác ¹
Tổn thương ở JZ (phân lớp trong, intrinsic)	• Có tiền sử phẫu thuật tại tử cung và rong kinh nặng² • Tiền sử sảy thai liên tiếp³

¹M Bourdon, et al., 2021. Hum Reprod

²M Bourdonet al., 2021. J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod

³C Exacoustos, et al., 2024. Reprod. Sci

Tương quan giữa đặc điểm Adenomyosis và triệu chứng



Tương quan giữa đặc điểm Adenomyosis và kết quả điều trị

Đặc điểm adenomyosis	Nguy cơ
Thể lan toả	• Tăng nguy cơ sẩy thai trong ba tháng giữa thai kỳ, ối vỡ sớm, tiền sản giật¹; • Tỷ lệ thai và trẻ sinh sống thấp hơn sau phẫu thuật bảo tồn²; • Tỷ lệ thai lâm sàng và tỷ lệ trẻ sinh sống thấp hơn sau điều trị IVF³
Thể khu trú	Kết cục sản khoa hoặc trẻ sinh sống tốt hơn so với thể lan toả; một số nghiên cứu cho thấy mối tương quan với hiếm muộn hoặc sẩy thai nếu tổn thương nằm ở JZ ^{1,2, 3, 4}
Tổn thương ở thành sau hoặc thành sau kèm theo thành trước	Các biến chứng sản khoa nghiêm trọng (nhau tiền đạo/nhau bám chặt, tiền sản giật, sinh non) chủ yếu gặp ở adenomyosis thành sau; adenomyosis ở thành trước và sau liên quan đến tiền sử sẩy thai nhiều hơn và tỷ lệ thai cộng dồn thấp hơn ⁵

¹Hashimoto et al., 2023. J. Matern. Fetal Neonatal Med.

²X. Chen, et al., 2025. J Minim Invasive Gynecol

³X.-L. Wang et al., 2023. AOGS

⁴A. Selntigia, et al., 2024. J. Clin. Med.

⁵J. Shi et al., 2023. Sci Rep

Tương quan giữa đặc điểm Adenomyosis và kết quả điều trị

Đặc điểm adenomyosis	Nguy cơ
Tổn thương ở JZ (phân lớp trong, intrinsic)	Nguy cơ sảy thai cao gấp ~3 lần ; adenomyosis thể lan tỏa, mức độ nặng ở JZ làm tăng thêm nguy cơ ¹
Tổn thương chỉ ở phân lớp ngoài	Tỷ lệ thai diễn tiến cao hơn so với nhóm có tổn thương ở JZ ¹
Thể trong (intrinsic) vs. thể ngoài (extrinsic)	Thể ngoài: tăng nguy cơ nhau bám bất thường; Thể trong, lan tỏa: biến chứng tăng huyết áp/nhiễm trùng nhiều hơn trong thai kỳ ^{2,3}
Thể trong (Internal) vs. thể không-trong (non-internal) trên siêu âm	Thể trong: Tỷ lệ trẻ sinh sống thấp hơn, tỷ lệ sảy thai sớm cao hơn, tỷ lệ PPRM cao gấp 3 lần, tuổi thai trung bình khi sinh thấp hơn, cân nặng khi sinh thấp hơn và nguy cơ thai nhỏ hơn so với tuổi thai (SGA) cao hơn ⁴

¹Cozzolino et al., 2024. Fertil Steril

²Hashimoto et al., 2023. J. Matern. Fetal Neonatal Med.

³Vannuccini and Petraglia, 2019. F1000Res

⁴Qi et al., 2026. RBMO

Bệnh nhân sinh năm 1988 (36 tuổi)

KN đều, 30 ngày; hành kinh 7 ngày, không thống kinh

Para: 1011

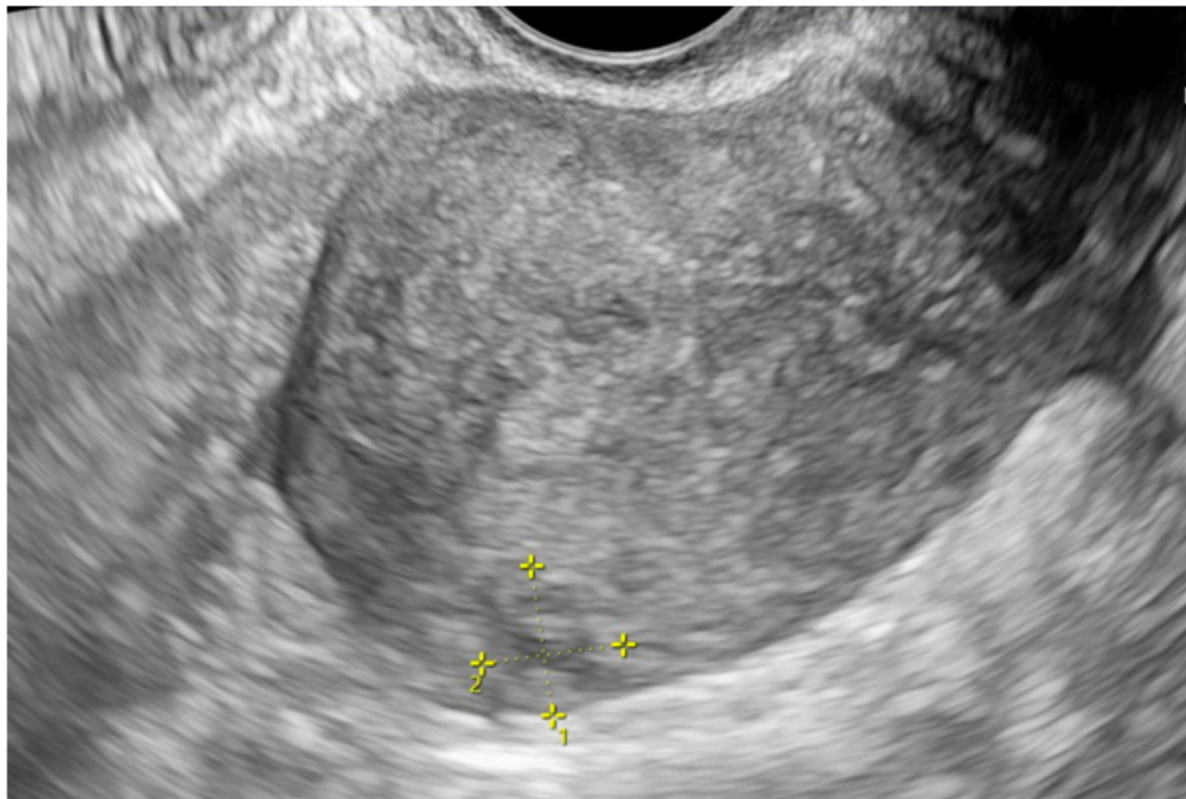
- 1 lần TNTC (T) năm 2017
- 1 lần mổ lấy thai năm 2021

IVF 1 (3/2024): trữ 4 N5/ 4 top. Chuyển phôi trữ 4 lần, beta-hCG âm tính, sử dụng phác đồ nội tiết ngoại sinh và chu kỳ tự nhiên.

IVF 2 (10/2024): trữ 2 N3/ 2 top + 1 N5/top

Chuyển lần 5: 1 phôi N5, beta-hCG âm tính, còn 2 N3 chưa chuyển

Các khảo sát thất bại làm tổ: chưa ghi nhận bất thường



KẾT QUẢ SIÊU ÂM

Họ và tên: [Redacted] Năm sinh: 1988 Giới tính: Nữ
Địa chỉ: [Redacted] Chi Minh
Khoa phòng: 3B - Siêu âm BS chỉ định: [Redacted]

VÙNG KHẢO SÁT : SIÊU ÂM PHỤ KHOA

**TỬ CUNG

Tư thế: ngã trước

Đường kính trước sau: 43 mm

Nội mạc tử cung: 5 mm

Mật độ: rải rác trong cơ tử cung có vài khối phản âm hỗn hợp, khối lớn nhất kích thước # 9x9.5 mm(L4)

Lòng tử cung: chưa phát hiện bất thường

**HAI PHÂN PHỤ:

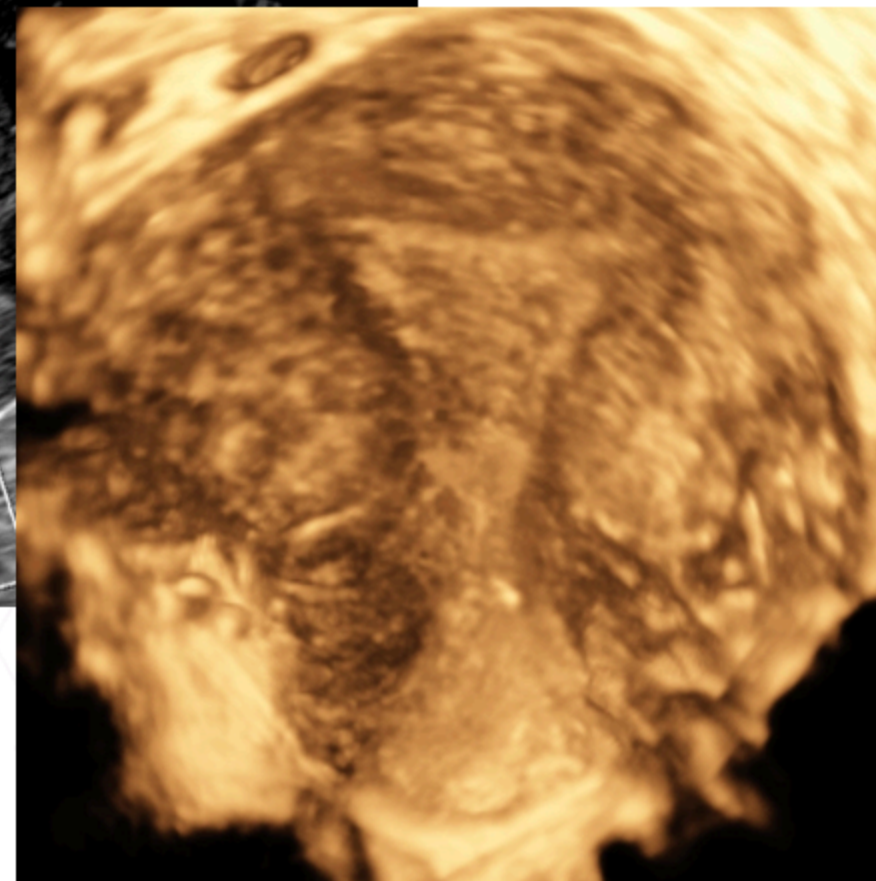
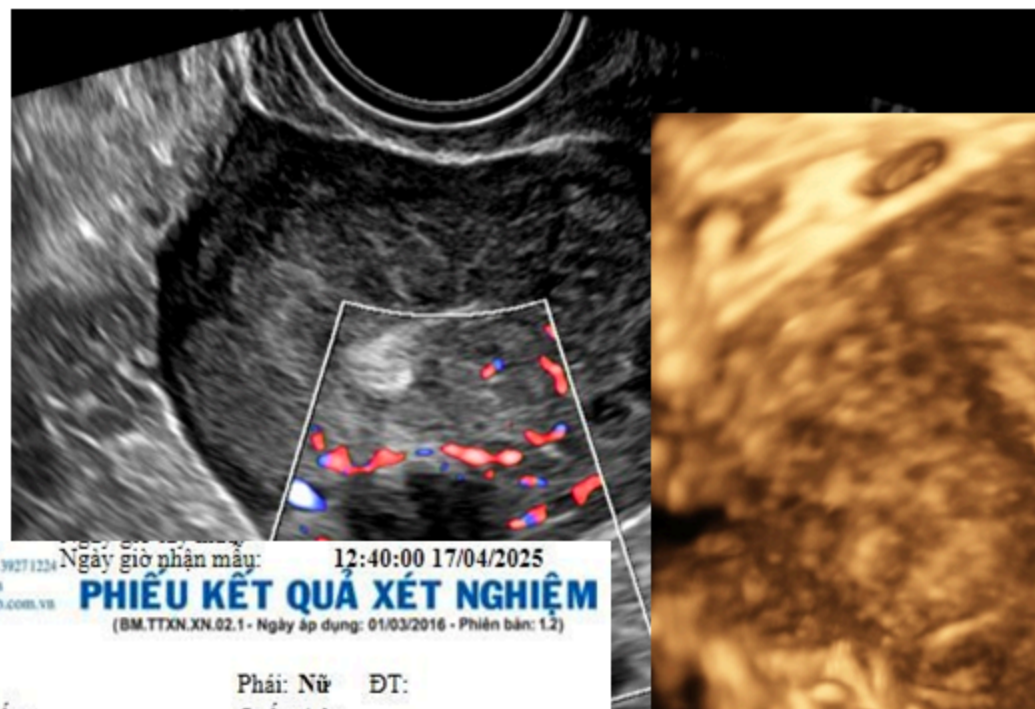
Buồng trứng phải: bình thường, có 6 nang thứ cấp

Buồng trứng trái: có nang phản âm hỗn hợp kích thước 34x43 mm, có 4 nang thứ cấp

DỊCH TÚI CUNG: không

**CÁC BẤT THƯỜNG KHÁC: chưa ghi nhận

KẾT LUẬN: ĐA U XƠ CƠ TỬ CUNG NHỎ (L4)
NANG XUẤT HUYẾT BUỒNG TRỨNG TRÁI
AFC= 10 (N2VK)



254 Hoa Hào - P.4 - Q.10 - TP.HCM
Tel: (028) 3927 0284 (Ext: 1134) - Fax: (028) 3927 1234
Email: hoahaomediclab@gmail.com
www.medic-lab.com / www.medic-lab.com.vn

Ngày giờ nhận mẫu: 12:40:00 17/04/2025

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
(BM.TTXN.XN.02.1 - Ngày áp dụng: 01/03/2016 - Phiên bản: 1.2)

Họ tên: [REDACTED] Phái: Nữ ĐT: [REDACTED]
Ngày tháng năm sinh: 1988 Số CCCD/Hộ chiếu: [REDACTED] Quốc tịch: [REDACTED]
Địa chỉ: [REDACTED]
Đơn vị: CTY CP BVMT ĐỨC PHÚ NHUẬN
BS yêu cầu: [REDACTED]
Loại mẫu: Máu Nơi lấy mẫu: [REDACTED] Tình trạng mẫu: Đạt

Chẩn đoán sơ bộ: [REDACTED]

TÊN XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	KHOẢNG THAM CHIẾU	MÃ QT
I. MIỄN DỊCH - IMMUNOLOGY			
CA 125 (O.M Cancer) ²	47.50 H (<35 U/mL)		QTMD031
II. XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ELISA - ELISA TEST			

Chẩn đoán:

Adenomyosis dạng nang, thể khu trú, nhóm 1 ở thành trước và sau, nhóm 3 ở thành sau tử cung / RIF

HIỂM MUỘN

**NGUY CƠ SẴY THAI
BIẾN CHỨNG THAI KỲ
THAI NHỎ SO VỚI TUỔI THAI**

Kết quả điều trị:

- **Chuyển lần 6:** điều trị 2 tháng GnRHa → chuyển 1 N3: beta-hCG (+) → thai lưu 8 tuần
- **Chuyển lần 7:** điều trị 2 tháng GnRHa → chuyển 1 N3: beta-hCG (+) → hiện thai diễn tiến 30 tuần.



KẾT LUẬN: MỘT THAI SỐNG TRONG TỬ CUNG
CN THAI NHI Ở BPV 13 CỦA TUỔI THAI 27 4/7 TUẦN (THEO DS 26/09/2026)
SIÊU ÂM DẤU HIỆU NGUY CƠ THAI NHI HIỆN CHƯA THẤY BẤT THƯỜNG

08:26 ngày 01/07/2026

Nói cùng một ngôn ngữ siêu âm: Chuẩn hóa mô tả theo cấu trúc 7 bước của MUSA giúp kết nối triệu chứng hình ảnh và lâm sàng trở nên hoàn thiện hơn.

Tập trung phân lớp: phân lớp tổn thương thành **nhóm trong (JZ)** và **nhóm ngoài (cơ ngoài)** để tư vấn cá thể hoá.

Ứng dụng siêu âm 3D: Sử dụng 3D TVS khảo sát đa mặt phẳng giúp phát hiện tốt nhất các bất thường JZ khi siêu âm 2D còn nghi ngờ, hạn chế bỏ sót chẩn đoán.

Xây dựng mô hình tiên đoán: Việc phân loại chi tiết adenomyosis tạo nền tảng cho nghiên cứu tương lai, cải thiện kết cục sinh sản và sơ sinh.



THANK YOU!

